Insuficiencia renal aguda y crónica

SEMIOLOGIA · Clase 36 · antes, dentro o después del riñón; y el riñón que se apaga

1 · IRA: FALLA BRUSCA CON TRES ORÍGENES

Prerrenal F2
llega poca sangre al riñón sano

Renal F2
daño directo del parénquima

Posrenal F2
obstrucción: la orina no sale

si falta perfusión causa

si se lesiona el parénquima

si se obstruye la salida

Insuficiencia renal aguda F1
falla brusca y global: acumula urea y creatinina; en principio reversible

si no se corrige, pasa a la

con túbulo sano se ve el

se produce por

Causas prerrenales F2
deshidratación, hemorragia, shock, sepsis, insuficiencia cardíaca, infarto, diuréticos

se produce por

Causas renales F2
aminoglucósidos, transfusión incompatible, glomerulonefritis, pielonefritis, lupus, vasculitis

sobre todo por

Causas posrenales F2
hiperplasia benigna de próstata (la más común en el varón), cálculo, coágulo, uréter ligado

si el túbulo muere, aparecen los

2 · BUSCAR EL SITIO: PRERRENAL FRENTE A RENAL

Prerrenal: túbulo sano F3
guarda el sodio: sodio urinario bajo y orina concentrada (cifras: 📚)

Renal: cilindros granulosos F4
células del túbulo muerto moldeadas; sodio alto sugiere necrosis tubular (📚)

el túbulo muerto lleva a la

al caer el filtrado, entra en la

3 · FASES DE LA IRA: LA OLIGÚRICA ES LA PELIGROSA

1 · Fase oligúrica F5
diuresis menor de 400 ml/24 h

sin eliminar potasio ni ácido da la

sin eliminar agua da la

al repararse sigue la

Hiperpotasemia y acidosis metabólica F5
sin orina no salen el potasio ni el ácido

Hipervolemia F5
edema, insuficiencia cardíaca izquierda y edema agudo de pulmón

2 · Fase poliúrica
el riñón se repara y orina mucho

sin corrección culmina en

sin corrección culmina en

termina en la

Paro cardiorrespiratorio si las complicaciones no se corrigen

3 · Recuperación
la creatinina desciende poco a poco

se convierte en

con manejo adecuado hay

con manejo inadecuado hay

Con buen manejo se recupera hasta el 90 % de la función: la IRA es reversible F1

Progresión a IRC
una IRA no resuelta o mal manejada se hace crónica

4 · IRC: PÉRDIDA DEFINITIVA DE NEFRONAS

Diabetes e hipertensión F9
las primeras causas: dañan la microcirculación renal

Otras causas
glomerulonefritis, lupus, pielonefritis, poliquistosis, obstrucción, IRA previa

también causan

son las primeras causas de

sin diabetes, en el anciano:

Insuficiencia renal crónica F1 · F6
falla global lenta e irreversible, con TFG menor de 60 ml/min

Varón de 70 años, PA 220/115, sin diabetes F9
probable nefropatía hipertensiva

se mide con la

resulta de la

Filtración glomerular normal F6
unos 120 ml/min (clearance 97-137 en varones, 88-128 en mujeres)

Pérdida progresiva de nefronas
reduce la reserva y culmina en uremia

por ser definitiva es

La pérdida es definitiva: la IRC no se revierte F1

avanza desde la

5 · ESTADIOS Y ANEMIA: AGUDA FRENTE A CRÓNICA

1 · Reserva disminuida
paciente asintomático

si se destruye el 75-90 %

2 · IRC compensada F7
75-90 % destruido: anemia y poliuria

si pasa del 90 %

ya da la

3 · IRC descompensada
más del 90 % destruido: uremia

Anemia F7
aparece desde la fase compensada porque hubo tiempo

ayuda a separar la IRC de la IRA:

La anemia habla de cronicidad; la aguda tiene causa reciente y suele no tenerla F7

6 · SÍNDROME URÉMICO Y DESENLACE

Caso del anciano de 70 años F10
IRC descompensada, crisis hipertensiva, insuficiencia cardíaca, anemia (Hto 22 %), K 7,5; creatinina 1,3 no cuadra

se ve en el

Síndrome urémico
se acumulan urea, potasio, fósforo y ácidos

tiñe la piel y da la

la uremia completa da el

deposita urea y da la

Piel pálida y amarillenta F8
pálida por la anemia, amarillenta por los cromógenos urémicos

Escarcha urémica y prurito
urea que sale por el sudor; aliento urémico

se agrava hacia las

se agrava hacia las

Complicaciones
HTA, insuficiencia cardíaca, encefalopatía, hiperpotasemia

conducen al

La etapa terminal requiere diálisis, hemodiálisis o trasplante renal

síndrome · causa · ejemplo · diagnóstico · concepto · complicación · desenlace · mecanismo · signo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología Médica 2020, U2 tema 10; Sotito 2018 U2-1; clase 10c — teoría del docente (📚 = literatura)